

Rappelez-vous que dans la chronologie d'apparition des systèmes de communication, votre système digestif est très précoce. Premier mouvement dans le système de communication est un mouvement fluide de type autocrine. En d'autres mots, je dois apprendre à me connaître. Une fois que je me connais, je peux échanger. Et puis seulement je peux digérer. Seulement après arrivera le système conjonctif circulatoire endocrinien. Regardez le système endocrinien, il est sous la dépendance de mon système circulatoire. D'abord, j'ai mon système entérique qui apparaît. Et puis seulement parasympathique et puis orthosympathique. Ça veut dire que mon premier cerveau, c'est digestif. Je n'ai pas d'abord été cérébralisé. J'ai d'abord été entérique. J'ai d'abord été digestif. N'oubliez pas les cinq grandes phases. Fécondation, gastrulation, neurulation, métamérisation et délimitation. Premier jour, j'ai un axe ici qui se met entre mes deux globules polaires. Cet axe est très important parce qu'il est à la base de mon développement digestif. À chaque fois que j'ai une division cellulaire ou que j'ai un clivage cellulaire, j'ai une augmentation de mon système métabolique. En d'autres mots... En d'autres mots, j'ai une augmentation de la membrane cellulaire. Mais à chaque fois que j'ai ça, j'ai une petite perte d'eau. Et donc, chaque fois que j'ai ce mouvement qui est continu dans cette phase de développement, cette puissance, ça va provoquer l'apparition d'une cavité qui s'appelle ici le blast cell. Eh bien, on peut voir ici la première image de votre système digestif. On peut dire que c'est l'ébauche de ta cavité viteline qui sera en fait intégrée dans ton tube digestif. Et on voit que cette cavité, elle n'est jamais centrée. Elle est toujours excentrée. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à la globalité de la polarité. On voit apparaître ce blast cell et on voit que l'embryon, ici, commence à s'organiser. Non seulement j'ai une organisation en micromère, c'est-à-dire en petites cellules, où on voit que j'ai un pôle végétal, un pôle gonflé, un pôle assimilateur. C'est-à-dire une force,

une puissance pour aller... Je vais rechercher l'information trophique. J'ai une cavité qui est le blast cell. Blast cell, ça veut dire blastocellé, le ciel, le germe du ciel. Je vais à un moment donné rechercher le ciel que je dois intégrer en un ciel intérieur. C'est-à-dire qu'au départ, mon système digestif, il est ouvert complètement à l'extérieur et il va petit à petit s'intégrer à l'intérieur. C'est pour ça que votre tube digestif, il représente une qualité qu'on appelle l'humus. J'ai un humus dans mon tube digestif. Cet humus, on peut le comparer à une flore intestinale. Donc la qualité vivante de mon intestin représente la qualité vivante de mon terroir dans lequel je suis nourri. Je suis d'abord à l'extérieur et le ciel en m'interroge. Dans la médecine chinoise, on parle de ça. Je réintègre ça à l'intérieur. La mise en place de la cavité viteline et du cellulome externe. Je suis intégré dans ma muqueuse utérine. J'ai ici un tissu qu'on appelle le trophoblast, cette couche noire. Ça, c'est un blast cell encore. Ça, c'est une cavité amniotique. Ça veut dire que je me construis dans ma phase de développement entre des couches liquidiennes. Je suis entouré de liquide. Je me développe dans ces liquides. Entre les deux, j'ai un tissu qui regarde ma cavité cellomique primitive. Ce sera mon système digestif. J'ai des cellules qui regardent ma cavité amniotique. Ce sera mon tissu ectodermique cérébral. Vous devez comprendre que c'est un processus en croissance organisé par des points d'appui, par la vitesse de croissance différentielle. Pour comprendre maintenant la mise en place de ma cavité viteline et de mon cellulome externe, la partie qui est périphérique ici, pour le noir, il est mis dans un bain trophique. Cette couche ici, comme elle est dans l'utérus, c'est la première couche qui reçoit l'information nutritive. Donc si je mange plus vite, je grandis plus vite. Mais comme la couche périphérique ici grandit très très vite, j'ai comme un déchirement entre ma couche périphérique et ma couche centrale. Ce déchirement va créer une couche de cellules qu'on appelle la membrane de Heusser qui garde

en contact ce qu'on appelle une cavité ici. Et j'ai la vitesse ici. Et ça va donner ce qu'on appelle un réticulum mésodermique, extra-embryonnaire. Et ce réticulum va grandir par rapport à ma périphérie. Ici on voit à un moment donné que ça se déchire ici. Et ce déchirement va faire que je vais passer d'un tissu qu'on appelle le blastocèle à un tissu qu'on appelle maintenant la cavité vitéline et le cellulome externe, une autre cavité. C'est dans cette phase que va apparaître ce pellicule embryonnaire primitif, organisé. Il était déjà là au moment où j'ai mon pellicule embryonnaire extra-primitif, au moment de l'intégration de l'embryon primitif, au moment de la nidation, qui est le premier contact avec la mère. Pas encore organisé. Et c'est cette phase-là qui va organiser une forme de S au sein même de mon bouton embryonnaire. Et là il y a un point d'appui très important qu'on a vu. Non seulement j'ai une organisation d'un pellicule, et non seulement j'ai un point d'appui entre un dôme d'expansion et un dôme d'impansion, au sein même de mon tissu, qui est l'ébauche pour la mise en place d'un processus adaptatif. C'est-à-dire que j'ai une formation axiale de mon embryon. Ça veut dire que cette phase ici va nous amener à cette phase notocordale. Une forme de S. Et cette forme de S va amener un mouvement qui est aussi impliqué par ce qu'on appelle un champ de perméation, un champ d'infusion et un champ de parméation, qui organise la vésicule amniotique vers l'avant et la vésicule viteline vers l'arrière. Et qui donne cette forme particulière de mon embryon, avec cette forme en S. Et ici j'ai un point d'appui. Les cellules qui sont dans la partie convergente vont grandir plus vite que les cellules qui sont dans la partie, on va dire, convexe ou concave. Avec un point d'appui ici qui est un point fixe. Ça s'appelait comment ce point ? La future base du crâne. On l'appelle le point zéro. C'est l'ébauche de ce qu'on appelle l'axe craniosacré primitif pur. Ça veut dire que je vais me retrouver avec un mouvement ici spécifique organisé par des champs d'acidité

ou basiques. On se retrouve avec deux types de pH différents dans ma cavité amniotique ou viteline. Avec ce qu'on appelle un canal neuroentérique de réorganisation de mon plan métabolique. Mais en même temps l'embryon commence à prendre sa forme ici avec ce processus axial qui se développe. Avec des phénomènes synchrones, qui fait que non seulement au moment où j'ai ce niveau-là, j'ai toute la rupture de mon asymétrie, mais j'ai un processus axial très important qui se développe. Ce processus axial ici, notochordal, est à la base du développement global de mon embryon. Et on avait vu que ce processus axial était un centre d'organisateur pour la totalité de mon embryon. Qu'il était organisé avec un point d'appui qu'on appelait la base du crâne et l'axe notochordal jusqu'à mon sacrum. j'allais me retrouver sur un plan ombilical. Donc on pourrait presque dire que je me développe entre mon ombilique et ma base du crâne. Mon cœur qui va donner mon diaphragme et mon foie. Il y a une intelligence dans mon développement. C'est comme si on te disait que c'était une invagination. Mais si on le voit dans la globalité et dans la croissance, c'est une évagination. Ça change quoi ? Ça change mon point d'appui. Si c'était une invagination, ce serait mon sacrum qui serait le point fixe. Mais finalement, le sacrum devient un fulcrum mobile comme mon sternum. Donc mon vrai point d'appui, c'est ramener mon sacrum dans son fulcrum embryonnaire pour lui redonner sa fonction primaire de réorganisation. Parce qu'à ce moment-là, j'ai différentes fonctions qui vont se développer. J'ai des superpositions. Non seulement j'ai un processus axial, donc vraiment un axe crânio-sacré primitif, mais en plus, au même moment, j'ai une rupture de la symétrie. C'est-à-dire que j'ai un flux nodal qui change l'aspect moléculaire de mon embryon sur un plan électrique, qui fait que j'ai des particules morphogènes qui vont se développer à côté. Et donc dans ce mouvement, j'ai toute l'organisation génomique qui se développe. Donc si je redonne un fulcrum embryonnaire, le corps sait

comment se réorganiser. D'abord le nombril, et puis le sphéno-basilaire, puis le cœur, puis le diaphragme, puis le foie, puis les surrénales, puis les gonadiques. En fait, mon sacrum, c'est quoi ? C'est la base du crâne. Je ne peux pas les séparer. Ce niveau-ci est mon fulcrum embryonnaire. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la future base du crâne et le sacrum, font un. C'est une unité fonctionnelle en fait. Il faut le comprendre dans sa fonction. J'ai donc un tissu de base plat. Par tout ce mouvement développemental, il y a une cavité qui se développe vers l'avant comme ceci, et cette vésicule viteline qui se développe vers l'arrière. Mais aussi des qualités intrinsèques. Ce qui fait que je passe d'un système en forme de S. Les cellules qui sont en regard de mon dôme vers l'avant vont se développer beaucoup plus vite que les cellules qui sont en arrière. Ce qui fait que globalement, si je regarde maintenant juste le vert dans sa globalité, dans la croissance, je constate ceci, que j'ai un point de non-croissance globale. Il va y avoir ce développement de cette base. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un point d'appui, qu'on appelle la future base du crâne. C'est-à-dire, c'est la pointe de ma notochorte. De part et d'autre, j'ai le cartilage para-axial, le cartilage hypophysaire, et qu'est-ce que va devenir le cartilage hypophysaire et le cartilage para-axial ? Le système occipital et le système sphénoïdal, qui est organisé avec une pointe ici, qui est un point d'appui global, ce qu'on appelle un point fixe, relatif, si tu veux, qui devient après, petit à petit, la zone où va se développer ce qu'on appelle le système occipital sphénoïdien, ici, qui est la résultante de ce mouvement développemental. Tu vois, quand je prends mon sacrum ici, c'est ce qu'on avait fait, je me connecte à son fulcrum embryonnaire. C'est-à-dire, je me connecte finalement à son point, ce que j'appelle l'image du Tao, moi, tu vois. Ici, j'ai un point, ici, tu vois, où le tissu ici est en hyperactivité, en hypoactivité, donc j'ai un point d'appui entre deux mouvements. Ce que j'appelle la force pré-morphogénétique,

qui n'a pas encore de forme de structure, mais qui contient son potentiel, est déjà à ce niveau-là, sur un plan sacro et occiput. Dès que j'ai ce point d'appui, le corps, il sait ce qu'il doit faire puisqu'il a son plan d'organisation. C'est une des premières choses qu'il fait, dans sa forme. Cette forme donne cet axe. Je prends mon sacrum, et ici, j'ai un axe de ton cordal, Il va avoir une régression de la structure, mais pas de ma fonction. Ma fonction est toujours là, parce qu'elle est primitif. Elle organise une structure, au niveau occipital, tu vois, et parfois, il y a des gens où c'est dévié. Ils ont des faux fulcrums. Ils ont des faux points d'appui. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à travailler avec la santé. Parce que ça, c'est la santé. Elle est toujours là. Au départ, c'est un champ, dense, et puis, dans la croissance, ça va se régresser. Ça veut dire que ma notochorte, quel est le vestige de ma notochorte ? C'est mon noyau pulposus. Donc, il y a une espèce de régression, dans le tissu. Mais l'axe, il est donné par ce moment-là. On va voir que ça, c'est ce qu'on appelle la ligne médiane. Trois lignes médianes, qu'on appelle la ligne médiane notochordale, la ligne médiane neuronale, et la ligne médiane qu'on avait étudiée la fois passée, la ligne médiane antérieure, digestif. On voit d'ailleurs ce qu'on appelle la linéa alba. Ça s'appelle la ligne blanche. Chez une femme enceinte, on voit encore cette ligne qui apparaît, tu vois, mais qui est la fermeture. Sur les testicules, on voit le scrotum. Chez la femme, on voit encore bien la ligne. Si vous regardez le palais, vous voyez tout cet axe. Bruno Cicli rajoute une quatrième, qui est un champ électrique, dont le point vital va se retrouver au niveau du hara. Plus précis, parce que c'est encore ombilical, mais si on regarde, il y a un vestige vasculaire qui va se retrouver, ce qu'on appelle un diverticule, organisé par mon plan ophalo-mésentérique, c'est-à-dire l'artère mésentérique supérieure. Non seulement j'ai une rupture de mon asymétrie, mais j'ai aussi, pendant ce moment-là, la mise en place de mon troisième tissu, ce qu'on appelle le tissu mésodermique

pur. J'ai mon axe notochordal, j'ai l'axe, ce qu'on appelle la ligne primitive, et le premier impulse du mouvement de mon tissu original épithélial est un tissu qui va d'abord organiser mon endoderme. Donc ça veut dire que mon ectoderme, ou ce que j'appelle l'épiblaste primitif de type ectodermique, va influencer déjà, par cette ligne primitive et par mon processus axial, mon système digestif dans son organisation. Puis après, je vais avoir mon mésoderme. Ce qui est d'abord primaire, c'est un champ électrique, c'est la polarité. On vient tous d'une cellule, et on vient tous de quel type de cellule ? On vient tous d'une cellule épithéliale, pas mésodermique. C'est un mouvement développemental, juste pour le foie, mais je ne peux pas le séparer de son contexte. J'ai un mouvement de flexion de mon embryon. Le mouvement de flexion de mon embryon va amener le cœur à sa place. Ça va créer une pression sur la vésicule vitéline supérieure, partie supérieure. Ça va intégrer des cellules qui sont au-delà de ma plaque précordale pour former un espace qui va délimiter la partie cardiaque de la partie péritoniale. Cette délimitation va créer quoi ? Va créer ce qu'on appelle le diaphragme primitif, septum transversum. Le flux d'informations arrive toujours, mais cette fois-ci, il arrive dans un compartiment différent. Donc le flux d'informations trophiques, le torrent d'eau qui arrive, va commencer à se congestionner sous le diaphragme. Et cet espace de congestion, sur un plan mésodermique, en relation avec le niveau entodermique, va créer une première ébauche qu'on appelle le foie. Mais l'embryon grandit. Et à un moment donné, mon foie, par des champs vasculaires qui vont se modifier, va grandir vers la droite. Il ne va pas tourner vers la droite. Il va grandir vers la droite. Et ça, c'est les mouvements embryonnaires. Je fais... Je peux me développer par là. J'ai l'espace. Comme le cœur, à un moment donné, on dit qu'il va vers la gauche. Non, il peut se développer par là. Il grandit par là. Donc ça veut dire que mes mouvements embryonnaires, c'est des

mouvements de développement en phase de croissance. C'est les forces internes d'expansion. C'est les artères, c'est les mouvements vasculaires qui décident. On s'organise autour de ton champ fluide. Et au cours de quoi ton champ fluide s'organise ? Ton champ électrique. Et d'où vient ça ? Finalement, du vide. Donc finalement, je m'organise dans le chaos. C'est l'axe notochordal qui va donner l'impulsion pour la plaque neurale. J'ai un tissu neural ici au-dessus, comme ça, qui est là. Tout va bien. Et puis tout d'un coup, il y a un axe notochordal qui arrive en dessous. Un truc bien axé. Un mouvement métabolique. Vous imaginez que le plafond ici, c'est ma plaque neurale. Et ici, j'ai ma notochorde. Dans le vide, ici, comme ça. Les cellules qui sont juste là sont ralenties dans leur croissance. Elles sont freinées. J'ai ici l'ectoderme primitif. J'ai ma notochorde qui a une information ici, avec un ralentissement, cette fois-ci, de nouveau. C'est des vitesses de croissance différentielles. C'est le même algorithme qui fait que la zone qui est ici, je ne grandis pas à la même vitesse. Par contre, ici, je commence à former ce qu'on appelle une gouttière. Tu vois ? Et cette gouttière ici, comme ça, change le compartiment mésodermique qui est ici. Et qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer un système vasculaire. C'est-à-dire que j'ai une trajectoire vasculaire qui s'organise. Dans mon algorithme de départ, le tissu mésodermique, le tissu interne, ne grandit pas à la même vitesse. Il devient un moteur parce qu'il amène l'information trophique. Il nourrit les cellules. Mais le tuyau, il ne grandit pas à la même vitesse. Il est ralenti, lui. Au-dessus, comme je mange à fond, je deviens obèse, je me développe et je m'enroule. Et c'est comme ça que va se développer le processus du corps. Si je prends un champ vasculaire ici primitif et que je mets derrière mon embryon ici, qui est comme ceci, on va dire, mon tube neural, ce qui se passe, c'est une croissance qui se fait comme ça. Avec un enroulement finalement, autour de ma zone cardiaque. Qui vient pousser sur la vésicule vitale,



une partie supérieure ici de ma vésicule qui va créer le septum transverseum. Le flot continu d'information qui arrive ici congestionne. Donc on peut dire que la cérébralisation entraîne la cardialisation qui entraîne la diaphragmatisation qui entraîne l'hépatisation. Après, il va y avoir un espace pulmonaire, donc il y a une pneumatisation qui va créer un espace qui va ouvrir un espace entre la partie postérieure et le foie ici qui va créer la surrénalisation. Pour avoir l'organisation et la mise en place définitive de mes gonades il me faut mes surrénales et mes reins. Donc on voit ici que la corte s'étend initialement de l'ébauche de la neurohypophyse du plancher du diencephale, future base du crâne. C'est le mouvement développemental du processus notochordal qui permettra le développement futur de ma base du crâne et de mon sacrum. Tandis que jusqu'à la membrane, il y a une cloacale, futur espace de développement pour le sacrum. La notochorte qui se mettra là qui est comme par hasard à la pointe du coup de sac de Douglas, la partie terminale de mon péritoine. On voit ici, tu vois, tout l'axe notochordal primitif avec ma base du crâne et mon sacrum. On voit ici, tu vois, ma notochorte jusqu'au niveau de ma base du crâne. Ici, mon processus notochordal, tu vois, jusqu'à ma base du crâne. Tu vois, la pointe de ce qu'on appelle le coup de sac de Douglas, la partie terminale est en relation avec ma notochorte. La flexion de l'embryon, bien comprendre cette dynamique fluide, on voit bien ici l'enroulement du développement de l'embryon. L'allongement, la croissance, mais regardez bien comme ça devient un point d'appui pour les tubes endocardiques. Tu vois le rapprochement de mes tubes endocardiques ici, parce qu'ils ne vont pas à la même vitesse. En fait, l'erreur sur ce dessin, c'est qu'on ne voit pas assez la croissance. Au moment où j'ai cette fermeture de mon tube neural, j'ai l'intégration de l'intestin pharyngien par exemple dans la partie caudale et j'ai en même temps la fermeture de mon tube neural. Donc le premier

28ème jour, j'ai l'intégration de mon cellulome externe en un cellulome interne, qui est pour la première fois un point d'appui sur un niveau du liquide céphalo-rachidien que j'ai intégré dans sa première personnalité. Je pars de mon pédicule embryonnaire et je reviens à mon pédicule embryonnaire. Je fais le mouvement pour moi du développement d'Uma-Eremaï. Peut-être qu'il était là dans sa fonction, là il devient dans sa structure. Donc ce qui est important de concevoir, c'est que je m'enroule autour de mon corps vasculaire. C'est pour ça qu'il faut toujours ramener les fluides vers le centre. On va voir dans le développement de mon système circulatoire que finalement, ça part de la périphérie vers le centre. Je dois me rassembler. Je plonge dans l'eau du tissu. Je plonge dans mon tissu. Je nage un peu au départ. Quand je trouve un mouvement, je trouve un point d'appui, un point de balance. Je fixe, après, l'analyse du tissu. Là tu rentres dans l'histoire du tissu de Becker's. Là tu rentres dans la mémoire. Il faut toucher le tissu là où il veut bien être reconnu et pas là où tu veux le reconnaître. Première chose, j'écoute son mouvement. Une fois que je trouve son point de balance, je rentre dans son histoire. À un moment donné, le tissu va te donner une image, un mot qui peut venir de loin, que ce soit sur un point embryonnaire ou même pour certains, la capacité transgénérationnelle.